

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090287-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: RAPHAELA GIANINNI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. INDISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5090287-12.2024.4.02.5101

510015083197 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090287-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: RAPHAELA GIANINNI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 40, DESPADEC1, autos de origem], em que o demandante pretendia a condenação solidária das rés ao fornecimento de "**bomba de infusão de insulina e insumos imprescindíveis para uso contínuo**", conforme prescrição do médico responsável, no prazo máximo de 72 horas, em razão de diagnóstico de **Diabetes Mellitus Tipo 1**.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova a existência da doença, a indispensabilidade dos insumos pleiteados, bem como a demora do Poder Público em prestar o devido atendimento.

Quanto ao **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo próprio quadro clínico desenhado pelos documentos médicos apresentados, demonstrando que a recorrente poderá sofrer diversas complicações derivadas dos episódios de hipoglicemia, podendo resultar em convulsões, coma e até mesmo morte.

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pela União [evento 11, CONTRAZ1] e pelo Estado do Rio de Janeiro [evento 13, PET1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Antes de adentrar a análise, vale registrar que as decisões liminares em matéria de saúde devem ser precedidas de parecer fornecido pelo NAT-Jus sempre que possível, com vistas a dar subsídio técnico ao convencimento do magistrado. Neste sentido é o Enunciado nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 18 *Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*

Neste sentido, os autos originários foram instruídos com dois pareceres do NAT-Jus, exarados, respectivamente, em 02/08/2024 [evento 18, PARECER1] e 25/09/2024 [evento 47, PARECER1].

Os pareceres confirmam que a bomba de infusão de insulina e os respectivos insumos estão indicados para tratamento do quadro clínico da demandante/recorrente:

*"Diante do exposto, informa-se que o uso de bomba de infusão de insulina - Sistema MiniMed 780G Start Kit e seus insumos: cateter "Set" com 60 cm de tubo de 9mm de cânula, aplicador Sill-seter "QuickSet", reservatório de 3ml, Guardian sensor 3 + adesivos para fixação, transmissor Guardian Link3, adaptador - Blue e Carelink USB pilhas Energizer AAA, **estão indicados ao manejo de quadro clínico da Autora** - histórico de hipoglicemias frequentes de forma grave, (Evento 1, ANEXO2, Página 6)." (grifo nosso)*

Lado outro, pontuou o NAT-Jus que o tratamento com a bomba de infusão pretendida não é essencial ou imprescindível para o tratamento do quadro clínico de Diabetes Mellitus Tipo 1 e, por isso, não consta da lista de dispensação do SUS. Não suficiente, indica a existência de alternativa terapêutica:

*"Salienta-se que o uso da bomba de insulina e seus acessórios apesar de necessário para o tratamento da Autora, **não é imprescindível**. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS) ou sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS), sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos5.*

(...)

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido7."

A posição do NAT-Jus não foi alterada no segundo parecer exarado após novo laudo médico [evento 32, LAUDO2]. Destaca-se, a propósito, que este novo laudo reforça que a demandante/recorrente apresenta boa resposta ao tratamento com as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, às quais tem acesso. Destaco o seguinte trecho:

"Paciente, 34 anos, com diabetes mellitus tipo 1, com boa adesão ao tratamento com insulinas análogos de longa e curta duração em esquema de múltiplas aplicações diárias, realizando contagem de carboidratos, dieta e atividade física. (...)"

Feitas tais considerações, tem-se que a demandante/recorrente pretende medicamento não dispensado pelo SUS e que, a despeito de indicado para seu quadro clínico, não se revela imprescindível, especialmente ante a existência de alternativas terapêuticas às quais tem acesso e apresenta bons resultados.

Consoante Tema 106 do STJ, em recursos repetitivos, o fornecimento de medicamento não constante da lista de dispensação do SUS depende da demonstração de sua imprescindibilidade e da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, o que, como se nota, não ocorre na espécie.

Tema 106 do STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

*Por todo o exposto, entendo ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, e **INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL**"*

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos pela recorrente, com vistas à revisão da alegada urgência.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.